



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN ETIK DAN DISIPLIN
PROFESI KEPERAWATAN
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 735.3/I-PND/KPW/VIII/2025

Tentang
Panduan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan

Disusun oleh :
Ketua Sub Etik dan Disiplin Keperawatan



Sherly Rosita, S. Kep., Ns

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes, AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan Panduan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan di Rumah Sakit Prima Husada.

Kode etik keperawatan adalah komponen dari etika kesehatan yang menegaskan nilai etika dalam bidang pemeliharaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan Disiplin profesi keperawatan adalah kepatuhan terhadap peraturan sesuai standar profesi keperawatan dan standar kepegawaian RS Prima Husada. Setiap staf keperawatan wajib menaati kode etik dan kaidah disiplin profesi keperawatan. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendukung terwujudnya mutu asuhan keperawatan yang berkualitas.

Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan/ asuhan keperawatan dan kebidanan, maka staf keperawatan sebagai pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi, etis dan peka budaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan panduan pelaksanaan etik dan disiplin profesi keperawatan sebagai acuan dalam implementasi etik dan disiplin profesi keperawatan di Rumah Sakit Prima Husada.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan panduan ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku panduan ini.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PANDUAN PENGENDALIAN MEKANIS DAN TEKNIS

1. dr. Nur Mazidah
2. Fariz Tiarawan Fadil Cahyono, S.Kep., Ns
3. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
4. Dhora Putri Meryda S.Kep., Ns
5. Arif Setya Pamuji, A.Md.Kep
6. Arnanda Nuryunita, A.Md.Kep
7. Tri Ani Darmawanti, A.Md.Kep
8. Amilatul Kholifah, A.Md. Kep
9. Saghita Puspita Sari A.Md.Kep

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABELvii

DAFTAR LAMPIRAN.....viii

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA ix

LAMPIRAN..... 1

BAB I 1

DEFINISI..... 1

BAB II 3

RUANG LINGKUP..... 3

 A. Etika Keperawatan 7

 B. Kode Etik Keperawatan..... 8

BAB III..... 10

TATA LAKSANA 10

 A. Penetapan Kriteria Pelanggaran Etik dan Disiplin 10

 B. Mekanisme Penanganan Masalah 10

 C. Pembinaan Etik dan Disiplin Profesi 11

 D. Pelanggaran dan Sanksi..... 12

 E. Prinsip Etik Dalam Penanganan Pelanggaran Etik dan Disiplin 16

BAB IV 19

DOKUMENTASI..... 19

BAB V 20

PENUTUP..... 20

DAFTAR PUSTAKA 21

LAMPIRAN..... 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Penanganan Masalah Pelanggaran Etik dan Disiplin	17
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pelanggaran Ringan	12
Tabel 2 : Pelanggaran Sedang	13
Tabel 3 : Pelanggaran Berat	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Format Pelaporan Pelanggaran Disiplin Profesi dan Etik Keperawatan	22
Lampiran 2 : Format Checklist Klasifikasi Pelanggaran	25
Lampiran 3 : Penyelesaian Masalah Etik dan Disiplin Profesi	30
Lampiran 4 : Laporan investigasi Pelanggaran Etik dan Disiplin Staff Keperawatan	31



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 735.3/I-PND/KPW/VIII/2025**

TENTANG

PANDUAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan Rumah Sakit Prima Husada Malang, maka diperlukan keputusan tentang panduan etik dan disiplin profesi keperawatan;
- b. Bahwa agar pelaksanaan etik dan disiplin profesi dapat berjalan dengan baik, perlu adanya panduan etik dan disiplin profesi keperawatan sebagai landasan bagi proses penegakan etik dan disiplin keperawatan bagi Komite Keperawatan RS Prima Husada Malang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b, maka dipandang perlu ditetapkan panduan pelaksanaan etik dan disiplin profesi keperawatan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Prima Husada Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
KEPERAWATAN.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

- (1) Panduan Etik dan Disiplin Keperawatan disusun untuk menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat serta bidan di Rumah Sakit Prima Husada.
- (2) Panduan ini menjadi acuan bagi Komite Keperawatan dalam penegakan etik dan disiplin keperawatan.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Panduan Etik dan Disiplin Keperawatan meliputi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan etika,
- b. Penerapan etika keperawatan,
- c. Penerapan kode etik keperawatan.

**BAB III
PELAKSANAAN ETIKA DAN DISIPLIN**

Pasal 3

- (1) Setiap perawat wajib menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan kode etik profesi, standar asuhan, dan kebijakan rumah sakit.
- (2) Prinsip etika dalam praktik keperawatan meliputi:
 - a. *Respect* (menghargai),
 - b. *Autonomy* (otonomi),
 - c. *Beneficence* (kemurahan hati),
 - d. *Non-maleficence* (tidak merugikan),
 - e. *Veracity* (kejujuran),
 - f. *Konfidensialitas* (kerahasiaan),
 - g. *Fidelity* (kesetiaan),
 - h. *Justice* (keadilan).

**BAB IV
TATA LAKSANA**

Pasal 4

- (1) Penanganan masalah etik dan disiplin dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Investigasi oleh Komite Keperawatan,
 - b. Rapat pleno untuk pengambilan keputusan,
 - c. Pemberian sanksi dan pembinaan.
- (2) Jenis pelanggaran dibagi menjadi:
 - a. Ringan,



- b. Sedang,
- c. Berat.

Pasal 5

Sanksi terhadap pelanggaran etik dan disiplin dapat berupa:

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis,
- c. Penengguhan kewenangan klinis,
- d. Pencabutan kewenangan klinis,
- e. Tindakan administratif sesuai peraturan rumah sakit.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Setiap tenaga perawat maupun bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit wajib mengikuti Panduan Etik dan Disiplin Keperawatan ini.

Pasal 14

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 08 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 735.3/I-PND/KPW/VIII/2025
TENTANG PANDUAN ETIK DAN
DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN

BAB I

DEFINISI

1. Direktur Utama adalah seseorang yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk menjabat posisi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam statuta Rumah Sakit Prima Husada Malang yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan mengelola rumah sakit.
2. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme staf keperawatan melalui mekanisme etik dan disiplin profesi keperawatan, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
3. Staf Keperawatan adalah perawat dan bidan yang terkait perjanjian dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di rumah sakit.
4. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan D3 perawat, Ners dan Ners Spesialis baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Kewenangan Klinis (*clinical nursing privilege*) adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang berhak dilakukan Oleh staf keperawatan di Rumah Sakit Prima Husada Malang sesuai dengan area praktik dan jenjang karirnya untuk suatu periode waktu tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
6. Panitia adhoc adalah panitia yang ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk membantu komite keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Etik adalah kesepakatan tentang praktik moral, keyakinan, sistem nilai, standart perilaku individu dan atau kaelompok tentang penilaian terhadap apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk.
8. Etika keperawatan adalah bagaimana perawat wajib bertigkah laku merujuk pada standar etik yang menentukan dan menuntun perawat dalam praktek sehari — hari
9. Etik dalam keperawatan adalah sistem perilaku/ keyakinan akan nilai-nilai untuk mengatur dan melindungi hak-hak individual, apa yang benar dan salah, apa yang harus dilakukan.
10. Kode etik keperawatan adalah komponen dari etika kesehatan yang menegaskan nilai etika dalam bidang pemeliharaan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang telah disusun Oleh Dewan Pusat PPNI melalui Musyawarah Nasional di Jakarta tentang Pemberlakuan Etik Keperawatan.

-
11. Disiplin profesi keperawatan adalah kepatuhan terhadap peraturan sesuai standar profesi keperawatan dan standar kepegawaian di RS Prima Husada Malang.
 12. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan keandirian klien dalam merawat dirinya.
 13. Penghargaan/*Reward* adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk promosi atau ucapan.
 14. Pembinaan adalah suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau sifat-sifat kepribadian sesuai dengan standar profesi keperawatan.
 15. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan
2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
4. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan
5. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

2.1 Pelaksanaan Pemeliharaan Etik

Pemeliharaan implementasi etika keperawatan sangat terkait dengan bagaimana perawat berperan dalam menjalankan tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Tanggung jawab adalah (*Responsibility*) adalah penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas- tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik (ANA, 1985 dalam Kemenkes, 2016). Agar memiliki tanggung jawab maka perawat diberikan ketentuan hukum dengan maksud agar pelayanan perawatannya tetap sesuai standar praktik keperawatan. Misal hukum mengatur apabila perawat melakukan tindakan kriminalitas, memalsukan ijazah, melakukan pungutan liar dan sebagainya. Tanggungjawab perawat ditunjukan dengan cara siap menerima hukuman (*punishment*) secara hukum kalau perawat terbukti bersalah atau melanggar hukum.

Tanggung jawab (*Responsibility*) perawat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Responsibility to God* (tanggung jawab utama terhadap Tuhannya) Dalam sudut pandang etika normatif, tanggung jawab perawat yang paling utama adalah tanggung jawab terhadap Tuhannya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Dalam sudut pandang etik pertanggungjawaban perawat terhadap Tuhannya terutama yang menyangkut hal-hal berikut ini:
 - a. Perawat harus melakukan tugasnya dengan niat yang tulus dan ikhlas sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdianya kepada Tuhan;
 - b. Mendoakan klien yang dirawatnya agar mendapat kesembuhan dari Tuhan;
 - c. Memberi dukungan psikologis kepada klien untuk dapat menerima sakit yang dideritanya dan mendapatkan hikmah dari pengalaman tersebut. Termasuk di dalamnya mempersiapkan klien tertentu untuk menghadapi maut jika penyakitnya tidak dapat disembuhkan (*end of life*);
 - d. Mendorong klien untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang memberikan kesembuhan kepadanya;
 - e. Bersama-sama dengan pemuka agama dalam membantu pemenuhan kebutuhan spiritual klien selama sakit.
2. *Responsibility to Client and Society* (tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat). Tanggungjawab perawat terhadap klien berfokus pada apa yang sudah dilakukan perawat terhadap kliennya mulai dari proses pengkajian sampai pada evaluasi dan dokumentasi asuhan.

Peran penting perawat adalah memberikan pelayanan perawatan (*care*) atau memberikan perawatan (*caring*). Tugas perawat bukan untuk mengobati (*cure*). Dalam pelaksanaan tugas di lapangan adakalanya perawat melakukan tugas dari

profesi lain seperti dokter, farmasi, ahli gizi, atau fisioterapi. Untuk tugas-tugas yang bukan tugas perawat seperti pemberian obat maka tanggungjawab tersebut seringkali dikaitkan dengan siapa yang memberikan tugas tersebut atau dengan siapa ia berkolaborasi. Dalam kasus kesalahan pemberian obat maka perawat harus turut bertanggungjawab, meskipun tanggungjawab utama ada pada pemberi tugas atau atasan perawat, dalam istilah etika dikenal dengan *Respondeath Superior*. Istilah tersebut merujuk pada tanggung jawab pemberi delegasi/ mandat terhadap perilaku salah yang dibuat penerima delegasi/ mandat sebagai akibat dari kesalahan dalam pendelegasian.

3. *Responsibility to Colleague and Supervisor* (tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan). Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab perawat terhadap rekan sejawat atau atasan. Di antaranya adalah:
 - a. Membuat pencatatan yang lengkap tentang tindakan keperawatan (kapan, frekuensi, tempat, cara, jenis tindakan, siapa yang melakukan) misalnya perawat A melakukan pemasangan infus pada lengan kanan vena brachialis, dan pemberian cairan RL sebanyak 5 labu, infus dicabut malam senin tanggal 30 Juni 2013 jam 21.00. Keadaan umum klien Compos Mentis, 120/80 mmHg, N=80x/m, R=28x/m, S=37C, kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas perawat;
 - b. Mengajarkan pengetahuan perawat terhadap perawat lain yang belum mampu atau belum mahir melakukannya misalnya perawat belum mahir memasang EKG diajari oleh perawat yang sudah mahir; Memberikan teguran bila rekan sejawat melakukan kesalahan atau menyalahi standar, misalnya bila perawat lain merokok di ruangan, memalsukan obat, mengambil barang klien yang bukan haknya, memalsukan tanda tangan, memungut uang di luar prosedur resmi, melakukan tindakan keperawatan di luar standar, misalnya memasang NGT tanpa menjaga sterilitas;
 - c. Memberikan kesaksian di pengadilan tentang suatu kasus yang dialami klien atau bila terjadi gugatan akibat kasus-kasus malpraktik seperti aborsi, infeksi nosokomial, kesalahan diagnostik, kesalahan pemberian obat, klien terjatuh, overhidrasi, keracunan obat, over dosis dsb. Perawat berkewajiban untuk menjadi saksi dengan menyertakan bukti-bukti yang memadai.

Sedangkan tanggung gugat dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya. Perawat hendaknya memiliki tanggung gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia menyatakan siap dan berani menghadapinya. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan profesinya. Perawat harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya.

Dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi tanggung gugat ini. Dokumen sebagai bukti asuhan keperawatan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Harapannya bahwa semua yang didokumentasikan adalah sesuai dengan apa yang dilakukan sehingga prinsip-prinsip etik termasuk kejujuran dapat terealisasi.

Pelaksanaan Pemeliharaan Etika dilakukan melalui sosialisasi tentang Prinsip-Prinsip Etik. Ada beberapa prinsip etik yang penting untuk praktik keperawatan (PPNI, 2003) yaitu:

1. *Respect* (Menghargai)
Respect diartikan sebagai perilaku perawat/bidan yang menghormati atau menghargai pasien/klien dan keluarganya. Perawat harus menghargai hak-hak pasien/ klien seperti hak untuk pencegahan bahaya dan mendapatkan penjelasan secara benar. Penerapan "informed consent" secara tidak langsung menyatakan suatu trilogi hak pasien yaitu, hak untuk dihargai, hak untuk menerima dan hak untuk

menolak treatment Perawat juga harus menghargai rekan-rekan kerjanya seperti dokter, ahli gizi, petugas kesehatan lainnya. Perawat adalah tenaga yang mempunyai kontak paling lama dengan pasien, dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan dengan cara yang relevan, tepat, empaty dan mudah dimengerti.

2. *Autonomy*

Pada prinsipnya otonomi berkaitan dengan hak seseorang untuk memilih bagi diri mereka sendiri, apa yang menurut pemikiran dan pertimbangannya merupakan hal yang terbaik. Dengan demikian akan melibatkan konsep diri dalam menentukan nasib atau mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.

3. *Beneficence* (kemurahan hati)

Kemurahan hati berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan hal yang baik dan tidak membahayakan orang lain. Kesulitan muncul pada waktu menentukan siapa yang harus memutuskan hal yang terbaik untuk seseorang. Permasalahan lain yang muncul berpusat pada apa yang disebut baik dan apa yang disebut tidak baik Sebagai contohnya adalah suatu keputusan yang harus diambil, apakah lebih baik, menopang dan memperpanjang hidup dalam menghadapi semua ketidakmampuan atau lebih baik memperbolehkan seseorang untuk meninggal atau mengakhiri penderitaannya

4. *Non-Maleficence* (tidak merugikan)

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat/bidan untuk tidak dengan sengaja menimbulkan kerugian atau cedera. Kerugian atau cedera dapat diartikan adanya kerusakan fisik seperti nyeri, kecacatan, kematian atau adanya gangguan emosi atau perasaan tidak berdaya, merasa terisolasi dan adanya kesalahan. Kerugian juga dapat berkaitan dengan ketidakadilan, pelanggaran atau berbuat kesalahan. Prinsip non maleficence adalah: jangan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, jangan menyebabkan nyeri atau penderitaan pada orang lain, jangan membuat orang lain tidak berdaya dan melukai perasaan orang lain

5. *Veracity* (Kejujuran)

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mengatakan suatu kebenaran, tidak berbohong atau menipu orang lain. Kejujuran adalah landasan untuk "informed concent" yang baik. Perawat harus dapat menyingkap semua informasi yang diperlukan oleh pasien maupun keluarganya sebelum mereka membuat keputusan

6. *Konfidensialitas* (Kerahasiaan)

Prinsip ini berkaitan dengan penghargaan perawat terhadap semua informasi tentang pasien/ klien yang dirawatnya. Pasien/ klien harus dapat menerima bahwa informasi yang diberikan kepada tenaga profesional kesehatan akan dihargai dan tidak disampaikan/ dibagikan kepada pihak lain secara tidak tepat. Perlu dipahami bahwa berbagi informasi tentang pasien/ klien dengan anggota kesehatan lain yang ikut merawat pasien tersebut bukan merupakan pembeberan rahasia selama informasi tersebut relevan dengan kasus yang ditangani.

Dalam praktik klinik perawat/bidan sering menemukan prinsip-prinsip yang bertentangan, sehingga mendapatkan kesulitan dalam menanganinya. Sebagai contoh: adanya pasien yang tidak diberitahu tentang diagnosa penyakitnya, sehingga dia bertanya kepada seorang perawat/bidan. Jika perawat tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan informasi ini, maka perawat akan mengalami dilema etik antara memberitahu pasien sesuai dengan penghargaan terhadap otonomi atau tidak akan menceritakan kebenaran yang berarti melanggar prinsip kejujuran

7. *Fidelity* (Kesetiaan)

Kesetiaan berkaitan dengan kewajiban untuk selalu setia pada kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat. Setiap tenaga keperawatan mempunyai tanggung jawab asuhan keperawatan kepada individu, pemberi kerja, pemerintah dan masyarakat. Apabila terdapat konflik diantara berbagai tanggungjawab, maka

diperlukan penentuan prioritas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

8. *Justice* (Keadilan)

Keadilan berkenaan dengan kewajiban untuk berlaku adil kepada semua orang, perkataan adil sendiri berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah, azas ini bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam transaksi dan pelayanan/ perlakuan antar individu pasien/klien, berarti setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kebutuhannya.

Nilai — Nilai yang Terkandung

1. Kesehatan dan kesejahteraan

Perawat peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan serta membantu orang lain mencapai tingkat kesehatan yang optimal dalam rentang situasi sehat normal, sakit, cedera atau dalam proses menghadapi kematian.

Perawat selalu peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam perilaku kehidupan sehari-harinya selalu berupaya untuk mencegah terjadinya kondisi penyimpangan kesehatan dan kesejahteraan melalui upaya pendidikan kesehatan, memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Perawat membantu memenuhi kebutuhan dasar klien apabila dirawat dan apabila hidup tidak bisa dipertahankan lagi, perawat berupaya untuk mengurangi penderitaannya dan membimbing dalam menghadapi kematian dengan damai dan bermartabat. Perawat berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah pelayanan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan melalui riset.

2. Pilihan

Perawat mendukung dan menghargai otonomi klien serta membantunya mengekspresikan kebutuhan dan nilai kesehatan serta mendapatkan informasi pelayanan yang tepat.

Perawat bertanggung jawab untuk mencari dan memberikan informasi yang lengkap tentang resiko dan keuntungan dari beberapa alternatif tindakan yang ditawarkan serta memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Apabila klien tetap menolak semua alternatif yang ditawarkan, perawat tetap berupaya agar menentukan pilihan yang mempunyai dampak paling kecil.

3. Martabat

Perawat menghargai dan mengadvokasi martabat dan kehormatan diri manusia.

Perawat dalam melaksanakan asuhan bertanggung jawab terhadap kebutuhan, nilai-nilai dan pilihan klien. Perawat juga mempunyai perhatian terhadap kelompok resiko serta mengadvokasi martabat klien dalam penggunaan teknologi di tatanan pelayanan kesehatan. Perawat mengobservasi kondisi kesehatan dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup bermartabat sepanjang hidupnya dan selama proses kematian.

4. Akuntabilitas

Perawat bertindak secara konsisten sesuai dengan standar praktik dan tanggung jawab profesi.

Perawat baik perawat klinik, manajer, pendidik maupun peneliti, harus menyadari tanggung jawab profesinya dan akuntabel dalam mengawal mutu asuhan keperawatan. Walaupun tanggung jawabnya berbeda namun semua berorientasi pada praktik keperawatan yang aman, kompeten dan berlandaskan etik.

A. Etika Keperawatan

Profesi keperawatan bentuk intervensinya adalah care atau peduli. Dengan

demikian segala prinsip-prinsip etik yang digunakan Oleh profesi keperawatan adalah dalam rangka memenuhi kepedulian. Dalam konteks kepedulian subjek yang berinteraksi diwujudkan dalam bentuk relasi. Relasi ini terjadi antara perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, perawat dengan organisasi tempat ia bekerja dan perawat dengan masyarakat luas sebagaimana yang termaktub dalam Kode Etik . Bila antara subjek yang berelasi saling menghargai dan tidak ada yang mendominasi, maka akan tercapai kebahagiaan. Namun bila ada subjek yang mendominasi, maka akan terjadi masalah etik yang berarti syarat-syarat untuk menjadi peduli tidak lagi dipenuhi. Terdapat 4 (empat) unsur utama dalam penerapan etik keperawatan yaitu *respect to others, compassion, advocacy dan intimacy*.

1. *Respect to others*, bertujuan untuk menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi adalah perawat dengan pasien, atau antar subjek lainnya. Seperti apa contoh *respect to patients* dalam hal ini yaitu perawat setiap memulai tugasnya hendaklah mengenalkan diri pada pasien. Apabila pasien sudah kenal dengan perawat, maka perawat hendaklah menyampaikan bahwa ia yang akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Demikian juga saat jam kerja berakhir, perawat berpamitan pada pasien. Inilah contoh nyata bagaimana sikap perawat menghargai pasien.
2. *Compassion*, secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa iba. Rasa iba ini juga dapat diartikan sebagai rasa sayang pada pasien dalam bentuk lisan dan sikap perilaku. Rasa sayang ini dapat dipelajari dengan cara melihat wajah pasien. Pada wajah pasien tergambarkan penderitaan akibat sakit yang dialami. Wajah akan memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kenalilah wajah pasien. Dari wajah ini akan menimbulkan belas kasih dari yang melihatnya.
3. *Advocacy*, berarti melindungi. Melindungi pasien supaya selamat selama berada dalam asuhan keperawatan pasien. *Advocacy* dapat dilakukan dengan cara menjamin intervensi yang diberikan perawat agar selalu aman. Hal ini dapat diperoleh bila perawat/bidan memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat/bidan tidak memiliki kompetensi, maka ia tidak layak diberi penugasan untuk intervensi tersebut.
4. *Intimacy*, adalah kedekatan, perawat/bidan terhadap pasien sangat dekat sekali. Dari mulai pasien kontak dengan perawat, pasien akan selalu beradadibawah pengawasan perawat. Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal dunia. Sedemikian dekatnya, sehingga dekat ini digambarkan sebagai ibu dekat dengan anaknya.

B. Kode Etik Keperawatan

Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas/fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat

dihindarkan.

Kode Etik Keperawatan dalam AD/ ART PPNI dan Indar (2017) adalah sebagai berikut:

1. Perawat dan klien

- a. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianutserta kedudukan sosial.
- b. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien.
- c. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
- d. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perawat dan praktek

Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus-menerus.

- a. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
- b. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan sertakualifikasi seseorang bilamelakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.
- c. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

3. Perawat dan Masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

4. Perawat dan teman sejawat

- a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
- b. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

5. Perawat dan profesi

-
- a. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.
 - b. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
 - c. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Penetapan Kriteria Pelanggaran Etik dan Disiplin

1. Kriteria Pelanggaran

- a. Pelanggaran Etik merupakan Pelanggaran terhadap dimensi etik merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap kode etik (sebagai aturan internal profesi).
- b. Pelanggaran Disiplin Merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap standar yang ditetapkan.
- c. Pelanggaran Hukum merupakan kesalahan yang mungkin timbul adalah penilaian benar-salah. Penilaian dilakukan oleh majelis disiplin bahkan perangkat hukum pidana

2. Faktor dan Dampak Pelanggaran

Kriteria pelanggaran etik ditentukan dengan beberapa faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut yaitu dampak:

- a. Keselamatan pasien
- b. Dampak pada profesi keperawatan
- c. Dampak pada organisasi dalam hal ini rumah sakit

Tata cara penentuan tingkat pelanggaran masalah etik dan disiplin tenaga keperawatan menggunakan aturan yang berlaku. Pelanggaran etika adalah perbuatan seorang perawat yang menyalahi kode etik keperawatan, dapat dikategorikan kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Pelanggaran Ringan: Tidak menimbulkan kerugian dan kecacatan fisik serta memiliki dampak risiko psikologi yang kecil
- b. Pelanggaran sedang: Tidak menimbulkan kerugian dan kecacatan fisik namun memiliki dampak terhadap psikologi
- c. Pelanggaran berat: Menimbulkan kerugian dan kecacatan fisik serta berpengaruh terhadap masalah psikologi.

B. Mekanisme Penanganan Masalah

Penanganan masalah etik dan disiplin profesi keperawatan Rumah Sakit Prima Husada Malang dilakukan melalui beberapa tahapan. Bila masalah etik dan disiplin profesi keperawatan tidak dapat diselesaikan di tingkat unit, maka kepala unit/ instalasi wajib melaporkan masalah tersebut ke komite keperawatan. Melalui mekanisme berikut:

- a. Komite keperawatan membentuk tim investigasi (adhoc) untuk menelusuri kebenaran laporan yang diterima.
- b. Laporan tim investigasi akan dibicarakan bersama dalam rapat pleno yang dihadiri oleh tim investigasi, kepala ruangan, kepala instalasi, kepala bidang keperawatan,

perawat/ bidan bersangkutan dan komite keperawatan (undangan, notulensi, daftar hadir).

- c. Bila keputusan yang diambil dalam rapat pleno memutuskan bahwa perawat/bidan terbukti melanggar etik dan disiplin profesi keperawatan, maka akan diberi surat peringatan tertulis pertama dan menjalani proses pembinaan (*coaching* dan/atau *counseling*).
- d. Pemberian peringatan tertulis kedua diberikan bila diterima laporan pelanggaran kedua kalinya.
- e. Komite keperawatan kembali melakukan investigasi melalui tim investigasi sebelumnya yang menangani masalah tersebut.
- f. Laporan tim ivestigasi akan dibicarakan bersama dalam rapat pleno yang dihadiri oleh tim investigasi, kepala ruangan, kepala instalasi, kepala bidang keperawatan, perawat/bidan bersangkutan dan komite keperawatan (undangan, notulensi, daftar hadir).
- g. Bila keputusan yang diambil dalam rapat pleno memutuskan bahwa perawat/bidan terbukti melanggar etik dan disiplin profesi keperawatan, maka akan diberi surat peringatan tertulis kedua dan menerbitkan surat rekomendasi pemutusan lewenangan klinis sementara ke Direktur Utama dan menjalani proses pembinaan (*coaching* dan/atau *counseling*).
- h. Bila ternyata, pelanggaran masih dilakukan dan dilaporkan, maka komite keperawatan akan melakukan koordinasi dengan bidang keperawatan, SDM RS dan Komite Etik dan Disiplin untuk dilakukan penyelesaian secara administratif.
- i. Bila keputusan yang diambil dalam rapat pleno memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik dan atau disiplin profesi, maka akan dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan dari komite keperawatan.

C. Pembinaan Etik dan Disiplin Profesi

Pembinaan adalah suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau sifat-sifat kepribadian sesuai dengan standar profesi keperawatan. Pembinaan etik dan disiplin profesi keperawatan dilakukan melalui proses *coaching* dan *counseling* dengan mekanisme pembinaan sebagai berikut:

- 1. Staf keperawatan yang telah diputuskan telah melanggar etik akan mendapatkan seorang *coach* dan/atau seorang counselor tergantung dari permasalahan yang dialami.
- 2. *Coach* dan/atau *counselor* direkomendasikan oleh komite keperawatan untuk melakukan pembinaan disiplin dan atau etik perawat/ bidan.
- 3. Proses *coaching* dan/atau *counseling* akan disesuaikan dengan perkembangan perilaku staf sebagai coachee.
- 4. Lama waktu yang digunakan untuk proses pembinaan tergantung dari kebutuhan disesuaikan perkembangan etik dan disiplin staf keperawatan.

5. Proses *coaching* dan *counseling* didokumentasikan dalam lembar *coaching* dan *counseling* oleh *coach* dan *counselor* serta lembar kontrol staf pada setiap sesi *coaching* dan/atau *counseling*.
6. *Coach* dan *counselor* akan membuat surat keterangan kondisi/perkembangan *coachee* yang dibina bila proses *coaching* dan/atau *counseling* telah selesai.

D. Pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran

Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi, sesuai dengan katagori pelanggaran yang telah dilakukan. Pada dasarnya, suatu norma etik adalah adalah norma yang apabila dilanggar "hanya" akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Sanksi adalah tindakan-tindakan untuk memaksa orang agar dapat menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan. Suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan/pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten) dan pencabutan hak praktek profesi. Sanksi tersebut diberikan dalam keputusan rapat/ sidang dengan membuktikan bahwa perawat tersebut melanggar etik (profesi) keperawatan. Adapun jenis pelanggaran berdasarkan berat ringannya pelanggaran di rumah sakit:

a. Pelanggaran Ringan

Tabel 1 : Pelanggaran Ringan

Objek Tanggung Jawab	Jenis Pelanggaran
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien	1. Membiarkan pasien dalam keadaan tidak rapi. 2. Tidak mengorientasikan tempat (ruangan) dan petugas kesehatan kepada pasien. 3. Memberi informasi yang tidak optimal. 4. Tidak melakukan 5 momen cuci tangan. 5. Kurang menunjukkan sikap empati. 6. Tidak memberi informasi pasien saat akan melakukan tindakan keperawatan. 7. Melakukan tindakan/ perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan atau ketenangan kerja (berbicara keras, menghidupkan radio, TV, dll
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Praktek	Tidak berusaha memahami berbagai prosedur dan kebijakan rumah sakit yang terkait dengan tugas sebagai perawat.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap	1. Kurang menghargai privacy, hasil kerja, martabat perawat lain atau profesi lain. 2. Tidak menghargai kelebihan/ prestasi perawat lain atau

Sesama Perawat dan Profesi Lain	profesi lain.Tidak menghormati hak sesama perawat dan atau tenaga kesehatan lain.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi	Berpenampilan tidak rapi, rambut tidak rapi / gondrong, tidak memakai pakaian dinas / seragam sesuai yang ditetapkan.

b. Pelanggaran Sedang

Tabel 2 : Pelanggaran Sedang

Objek Tanggung Jawab	Jenis Pelanggaran
<i>Setiap pelanggaran ringan yang sudah dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali dianggap pelanggaran sedang.</i>	
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien	1. Tidak memperhatikan kebersihan diri pasien, memandikan, menggosok gigi/ <i>oral hygiene</i> , <i>vulva hygiene</i> . 2. Memberi informasi yang tidak bertanggung jawab yang membuat kecemasan pada pasien dan keluarga. 3. Tidak memberikan bimbingan rohani / menunjuk pada pemuka agama pada saat pasien membutuhkan/ dalam sakratul maut. 4. Melakukan tindakan keperawatan tidak sesuai dengan SPO yang dapat merugikan pasien tetapi tidak membahayakan jiwa. 5. Bersikap judes dan tidak ramah dalam melayani pasien/ keluarga (laporan tertulis/ lisan / kotak saran). 6. Tidak membantu memenuhi kebutuhan eliminasi pada pasien yang butuh bantuan. 7. Tidak melakukan prosedur teknik aseptik yang mengakibatkan terjadi infeksi. 8. Tidak melakukan tindakan pencegahan dekubitus (mengubah posisi, memberi pelembab, bedak, <i>massage</i> , mengganti alat tenun yang basah/ kotor). 9. Mengabaikan kebutuhan pasien karena sibuk melakukan aktivitas pribadi (bermain HP, menonton TV, dll)
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Praktek	1.Menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur tetap dan kebijakan rumah sakit yang berlaku. 2. Tidak melakukan antisipasi terhadap keamanan kenyamanan pasien. 3. Tidak memelihara mutu pelayanan dan asuhan keperawatan secara optimal. 4. Tidak melakukan evaluasi setelah melakukan tindakan

	keperawatan (respon pasien, kondisi pasien dll). 5. Tidak mawas dalam melaksanakan tugas keperawatan.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Lain	1. Tidak mau bekerjasama dalam tugas dengan sesama perawat atau profesi lain. 2. Tidak mau membantu perawat lain dalam menjalankan tugas saat dibutuhkan. 3. Tidak memelihara suasana kerja yang harmonis dan kondusif. 4. Melemparkan tanggung jawab kepada perawat lain. 5. Tidak mau memberi transformasi ilmu, keterampilan dan pengalaman kepada perawat lain atau profesi lain. 6. Tidak mau menerima pengetahuan, pengalaman, keterampilan dari semua perawat dan profesi lain dalam rangka meningkatkan keterampilan di bidang keperawatan. 7. Membicarakan kekurangan atau keburukan perawat lain di depan pasien dan/atau keluarga pasien.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi Keperawatan	1. Menolak untuk meningkatkan pendidikan formal dan non-formal 2. Tidak berupaya meningkatkan kemampuan profesional. 3. Tidak menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukan perilaku dan sifat pribadi yang tercela, menjelekkan profesi perawat atau organisasi profesi, mengeluarkan kata-kata kotor saat berdinas. 4. Meninggalkan /tidak dinas selama 1 hari tanpa izin

c. Pelanggaran Berat

Tabel 3 : Pelanggaran Berat

Objek Tanggung Jawab	Jenis Pelanggaran
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien	1. Tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, cairan elektrolit. 2. Tidak memenuhi kebutuhan oksigenisasi, kebersihan jalan nafas. 3. Tidak memperhatikan/ mempertahankan sirkulasi kardiovaskuler. 4. Tidak bertindak pada saat pasien dalam keadaan sekarat/ henti jantung/ pain (kecuali keinginan keluarga). 5. Tidak memperhatikan keamanan pasien (pasien jatuh, tergelincir, keracunan, salah obat, salah transfusi dll). 6. Melakukan tindakan Keperawatan yang tidak sesuai prosedur tetap yang dapat menyebabkan kematian/

	kecacatan. 7. Memberikan informasi yang tidak benar/ tidak dapat dipertanggung jawabkan. 8. Meminta imbalan kepada pasien dan/atau keluarga pasien. 9. Tidak menjaga kerahasiaan pasien/ keluarga pada profesi/ orang yang berhak mengetahui. 10. Komunikasi yang tidak baik dan dimuat di media massa/media sosial. 11. Tidak menghargai agama pasien/ keluarga. 12. Membedakan pelayanan keperawatan terhadap pasien berdasarkan status sosial dan martabat pasien.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Praktek	1. Berulang kali melakukan tugas yang tidak sesuai dengan prosedur tetap dan kebijakan rumah sakit yang dapat merugikan pasien secara fisik mental dan material. 2. Tidak memegang teguh rahasia jabatan. 3. Bekerja dengan mempertimbangkan kesukuan, jenis kelamin, aliran politik, agama dan status sosial sesuai dengan keinginan pribadi.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Lain	1. Bertengkar dengan perawat atau profesi lain. 2. Melakukan tindakan tidak etis terhadap sesama perawat atau profesi lain. Mencelakakan perawat dan profesi lain. 3. Mengadu domba sesama perawat atau profesi lain. 4. Melindungi perbuatan teman yang tidak etis/praktek legal.
Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi Keperawatan	1. Mengkomersialkan memperjual belikan harta rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau profesi keperawatan. 2. Menjual nama organisasi profesi Keperawatan untuk kepentingan pribadi, mencari dana atas nama profesi lain untuk kepentingan pribadi, promosi produk tertentu dikaitkan dengan profesi untuk kepentingan pribadi. 3. Menggunakan obat-obat terlarang/ alkohol/ merokok saat bertugas. 4. Meninggalkan tugas selama lebih dari sekali dalam satu bulan ketika dinas pagi, sore, malam tanpa izin. 5. Meninggalkan/ tidak dinas selama lebih dari satu kali dalam satu bulan tanpa izin.

2. Tindakan Disiplin dan Sanksi

Tindakan disiplin merupakan tindakan yang dilakukan terhadap staf

keperawatan yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin dalam rangka meningkatkan kinerja personal, semangat kerja dan pengembangan personal. Sedangkan sanksi adalah seluruh tindakan positif yang diambil dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan keperawatan, melindungi nama baik profesi dan melindungi keselamatan pasien serta hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan personal maupun nama baik profesi keperawatan.

a. Sanksi didasarkan pada:

- 1) Jenis pelanggaran
- 2) Frekuensi (seringnya/ pengulangan) pelanggaran.
- 3) Unsur kesengajaan

b. Bentuk sanksi yang diberikan akibat terjadinya pelanggaran etik dan disiplin adalah:

- 1) Teguran/peringatan lisan hanya berlaku di tingkat unit atau pihak komite keperawatan menemukan langsung pelanggaran saat kunjungan ke unit-unit.
- 2) Teguran tertulis diberikan oleh komite keperawatan untuk jenis pelanggaran sedang.
- 3) Rekomendasi penangguhan/ pemutusan/ pencabutan kewenangan klinis sementara. Staf keperawatan yang kewenangan klinisnya ditangguhkan oleh subkomite etik dan disiplin profesi, maka staf tersebut tidak diperkenankan melakukan tindakan keperawatan/ kebidanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- 4) Rekomendasi Pencabutan kewenangan klinis tetap.
- 5) Rekomendasi tindakan administratif untuk pelanggaran berat.

c. Penatalaksanaan pemberian sanksi

- 1) Subkomite etik dan disiplin profesi keperawatan dalam hal ini Komite Keperawatan berwenang memberi sanksi bagi staf keperawatan yang melakukan pelanggaran dan diproses di Komite Keperawatan.
- 2) Perbuatan pelanggaran etik atau disiplin profesi dapat berasal dari laporan atau temuan langsung saat kunjungan ke unit yang bersangkutan (staf keperawatan).

E. Prinsip Etik Dalam Penanganan Pelanggaran Etik dan Disiplin

1. Indipendensi

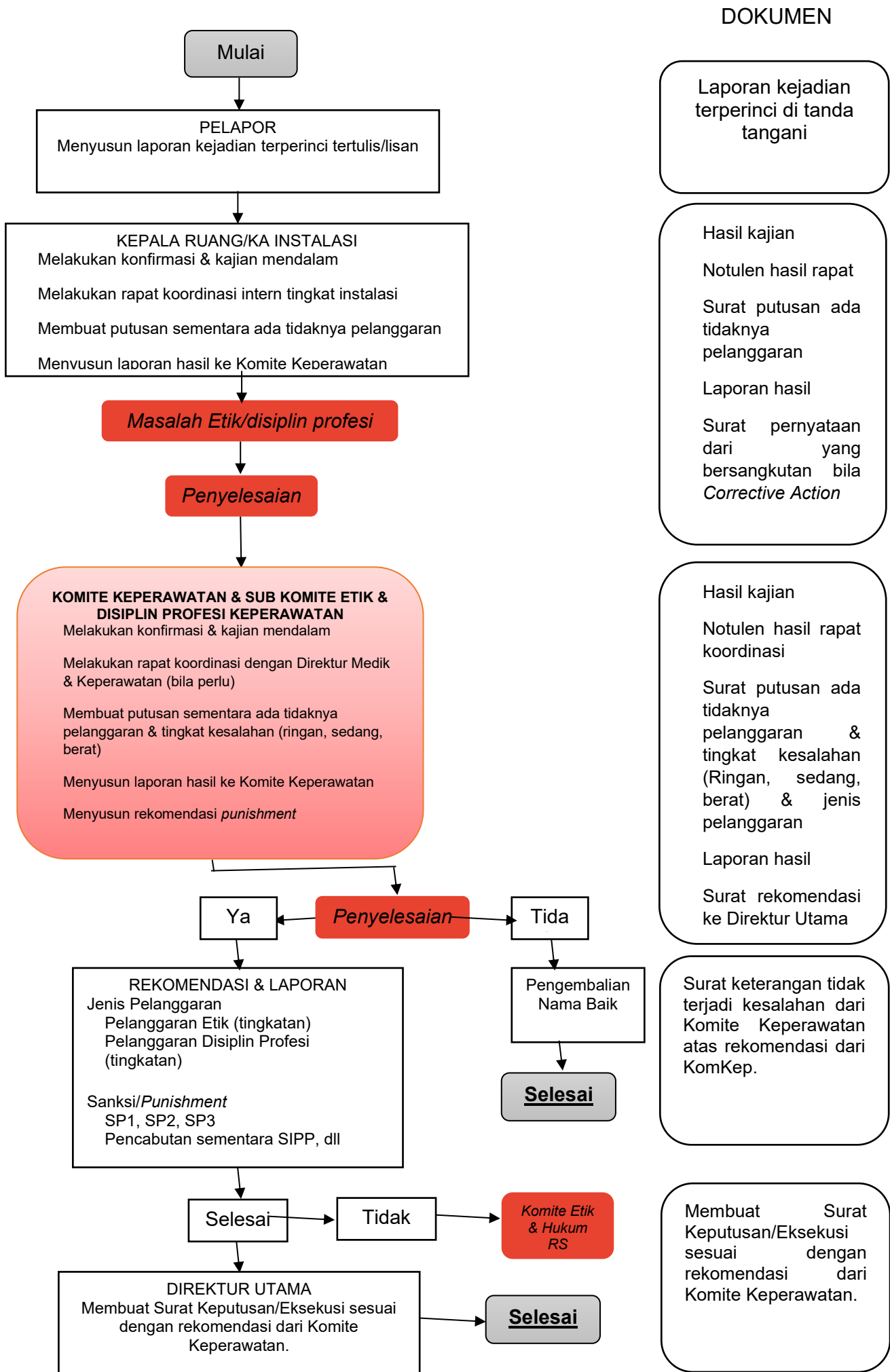
Dalam melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh apapun termasuk hubungan baik, hubungan saudara, atasan kerja, pemberian sesuatu pun dan ras, suku, agama dll

2. Praduga tidak bersalah

Memiliki persepsi atau opini bahwa pihak yang terduga melakukan pelanggaran etika, disiplin dan hukum yang sedang di tangani adalah tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah baik oleh tim yang berwenang atau oleh pengadilan.

-
3. Penghargaan terhadap profesi dan lembaga
Dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mencederai kewibawaan tim yang berwenang, organisasi profesi maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga lain yang teralibat di dalamnya.
 4. Akuntabilitas
Semua tim dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pelanggaran etik dan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang dilakukan sampai pada putusan yang diberikan pada terduga pelanggaran etik, disiplin dan hukum.
 5. Kehati-hatian dan kerahasiaan
Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum dilakukan secara hati — hati dan hasilnya bersifat rahasia
 6. Objektifitas
Prinsip objektifitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan penanganan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum dilakukan dengan parameter yang jelas.
 7. Efektif dan efisien
Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan dan penanganan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum dilakukan dengan tepat waktu tepat sasaran.
 8. Perlakuan yang sama
Perlakuan yang sama bahwa setiap kegiatan pemeriksaan dan penanganan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum pihak pelapor dan pihak terlapor diberikan kesempatan yang sama.
 9. Prinsip perilaku rendah hati
Prinsip perilaku rendah hati dimaksudkan setiap kegiatan pemeriksaan dan penanganan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum harus dilakukan dengan rasa empati dan tidak berbicara kasar serta menyudutkan.

Gambar 1 : Alur Penanganan Masalah Pelanggaran Etik dan Disiplin



BAB IV DOKUMENTASI

Informasi dari proses pendampingan dan penyelesaian masalah etik dan disiplin profesi keperawatan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk *file* anggota staf keperawatan fungsional dan file lainnya yang relevan.

Proses etik dan disiplin profesi staf keperawatan staf keperawatan merupakan suatu proses pengumpulan data, menganalisa informasi dan penyelesaian masalah terhadap setiap masalah etik maupun disiplin staf keperawatan yang dilaksanakan berdasarkan data yang komprehensif untuk menilai pencapaian program dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adanya proses etik dan disiplin profesi staf keperawatan secara terus menerus diharapkan tercapainya pelayanan keperawatan profesional yang bermutu dan berdaya saing.

BAB V

PENUTUP

Panduan etik dan disiplin staf keperawatan mempunyai peranan penting untuk panduan kerja bagi para perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Panduan ini dapat digunakan juga sebagai acuan kerja bagi tenaga keperawatan / kebidanan.

Penyusunan panduan etik dan disiplin staf keperawatan ini adalah merupakan langkah awal sebagai suatu proses yang panjang sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan komite keperawatan dan tujuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan sampai paripurna.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 08 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Forum Komite Keperawatan Indonesia. (n.d.). *Panduan Kredensial*. Jakarta: RKKI.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Utami, N. W. (2016). *Etika Keperawatan dan Keperawatan Professional*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, Kemenkes RI.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Elektronik Pelaporan Pelanggaran Disiplin Profesi dan Etik Keperawatan



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

Laporan Pelanggaran Disiplin Profesi dan Etik Perawat/Bidan

Formulir ini bersifat **RAHASIA, TIDAK BOLEH DISALIN** untuk pihak yang tidak berkepentingan.

kppirsphmalang@gmail.com

Ganti akun

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

Email Anda

Berikutnya

Kosongkan formulir

Data Identitas Individu

Isikan data identitas sebenar-benarnya.

Nama : *

Jawaban Anda

Jenis Kelamin : *

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Umur : ... (tahun) *

Jawaban Anda

Alamat : *

Jawaban Anda

22

Masa kerja di rumah sakit : * Jawaban Anda
Tahun masuk RS : * Jawaban Anda
Masa kerja unit kerja saat ini : * Jawaban Anda
Tahun masuk unit kerja saat ini: * Jawaban Anda
Peringkat kompetensi akhir (PK) : * ☐ Pra PK ☐ PK 1 ☐ PK 2 ☐ PK 3 ☐ PK 4 ☐ Yang lain:
Masa kerja kompetensi : * Jawaban Anda
Kembali Berikutnya Kosongkan formulir

Laporan Masalah

Tanggal dan waktu kejadian : *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Waktu

.

Unit kerja tempat kejadian masalah : *

Pilih

Lokasi kejadian masalah : *

Jawaban Anda

Jenis Masalah : *

☐ Kode Etik Perawat

☐ Pelanggaran Disiplin Profesi

Kembali

Berikutnya

Kosongkan formulir

JENIS MASALAH : KODE ETIK PERAWAT

Jenis masalah kode etik perawat : *

☐ Perawat dan klien

☐ Perawat dan praktik

☐ Perawat dan masyarakat

☐ Perawat dan teman sejawat

☐ Perawat dan profesi

JENIS MASALAH : PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI

Jenis masalah Pelanggaran disiplin profesi : *

☐ Standar Manajemen

☐ Standar Pelayanan

☐ Standar Asuhan

☐ Standar Profesi

☐ Standar Profesional

☐ Standar Etika

24

Upaya pembinaan tingkat unit yang telah dilakukan : *

Jawaban Anda

Hasil pembinaan unit : *

Jawaban Anda

Kronologis Masalah : *

(Kronologis dapat dilampirkan pula dalam lembar terpisah dan dibubuhi tanda tangan serta nama jelas yang diupload pada form ini.)

Jawaban Anda

Upload kronologis masalah :

Upload maksimum 5 file yang didukung. Maks 100 MB per file.

 Tambahkan file

Akibat Masalah : *

Jawaban Anda

Pengirim Laporan : (Nama Jelas) *

Jawaban Anda

Tanggal melapor : *

Tanggal

dd/mm/yyyy 

Kembali

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

Lampiran 2 : Formulir Checklist Klasifikasi Pelanggaran

FORMULIR CEKLIST KLASIFIKASI PELANGGARAN

(Komite Keperawatan RS Prima Husada)

Tingkat Pelanggaran	Objek Tanggung Jawab	Jenis Pelanggaran	Check list	Keterangan
Pelanggaran Ringan	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien	1. Membiarkan pasien dalam keadaan tidak rapi.	☐	
		2. Tidak mengorientasikan tempat (ruangan) dan petugas kesehatan kepada pasien.	☐	
		3. Memberi informasi yang tidak optimal.	☐	
		4. Tidak melakukan 5 momen cuci tangan.	☐	
		5. Kurang menunjukkan sikap empati.	☐	
		6. Tidak memberi informasi pasien saat akan melakukan tindakan keperawatan.	☐	
		7. Melakukan tindakan/ perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan atau ketenangan kerja (berbicara keras, menghidupkan radio, TV, dll.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Praktek	1. Tidak berusaha memahami berbagai prosedur dan kebijakan rumah sakit yang terkait dengan tugas sebagai perawat.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Lain	1. Kurang menghargai privacy, hasil kerja, martabat perawat lain atau profesi lain.	☐	
		2. Tidak menghargai kelebihan/ prestasi perawat lain atau profesi lain.Tidak menghormati hak sesama perawat dan atau tenaga kesehatan lain.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi	1. Berpenampilan tidak rapi, rambut tidak rapi / gondrong, tidak memakai pakaian dinas / seragam sesuai yang ditetapkan.	☐	
Pelanggaran Sedang	Setiap pelanggaran ringan yang sudah dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali dianggap pelanggaran sedang.		☐	

	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien	1. Tidak memperhatikan kebersihan diri pasien, memandikan, menggosok gigi/oral hygiene, vulva hygiene.	☐	
		2. Memberi informasi yang tidak bertanggung jawab yang membuat kecemasan pada pasien dan keluarga.	☐	
		3. Tidak memberikan bimbingan rohani / menunjuk pada pemuka agama pada saat pasien membutuhkan/ dalam sakratul maut.	☐	
		4. Melakukan tindakan keperawatan tidak sesuai dengan SPO yang dapat merugikan pasien tetapi tidak membahayakan jiwa.	☐	
		5. Bersikap jutek dan tidak ramah dalam melayani pasien/ keluarga (laporan tertulis/ lisan / kotak saran).	☐	
		6. Tidak membantu memenuhi kebutuhan eliminasi pada pasien yang butuh bantuan.	☐	
		7. Tidak melakukan prosedur teknik aseptik yang mengakibatkan terjadi infeksi.	☐	
		8. Tidak melakukan tindakan pencegahan dekubitus (mengubah posisi, memberi pelembab, bedak, massage, mengganti alat tenun yang basah/ kotor).	☐	
		9. Mengabaikan kebutuhan pasien karena sibuk melakukan aktivitas pribadi (bermain HP, menonton TV, dll).	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Praktek	1. Menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur tetap dan kebijakan rumah sakit yang berlaku.	☐	
		2. Tidak melakukan antisipasi terhadap keamanan kenyamanan pasien.	☐	
		3. Tidak memelihara mutu pelayanan dan asuhan keperawatan secara optimal.	☐	

		4. Tidak melakukan evaluasi setelah melakukan tindakan keperawatan (respon pasien, kondisi pasien dll).	☐	
		5. Tidak mawas dalam melaksanakan tugas keperawatan.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Lain	1. Tidak mau bekerjasama dalam tugas dengan sesama perawat atau profesi lain.	☐	
		2. Tidak mau membantu perawat lain dalam menjalankan tugas saat dibutuhkan.	☐	
		3. Tidak memelihara suasana kerja yang harmonis dan kondusif.	☐	
		4. Melemparkan tanggung jawab kepada perawat lain.	☐	
		5. Tidak mau memberi transformasi ilmu, keterampilan dan pengalaman kepada perawat lain atau profesi lain.	☐	
		6. Tidak mau menerima pengetahuan, pengalaman, keterampilan dari semua perawat dan profesi lain dalam rangka meningkatkan keterampilan di bidang keperawatan.	☐	
		7. Membicarakan kekurangan atau keburukan perawat lain di depan pasien dan/atau keluarga pasien.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi Keperawatan	1. Menolak untuk meningkatkan pendidikan formal dan non-formal.	☐	
		2. Tidak berupaya meningkatkan kemampuan profesional.	☐	
		3. Tidak menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukan perilaku dan sifat pribadi yang tercela, menjelekkan profesi perawat atau organisasi profesi, mengeluarkan kata-kata kotor saat berdinis.	☐	
		4. Meninggalkan /tidak dinas selama 1 hari tanpa izin.	☐	

Pelanggaran Berat	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien	1. Tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, cairan elektrolit.	☐	
		2. Tidak memenuhi kebutuhan oksigenisasi, kebersihan jalan nafas.	☐	
		3. Tidak memperhatikan atau mempertahankan sirkulasi <i>cardiovaskuler</i> .	☐	
		4. Tidak bertindak pada saat pasien dalam keadaan sekarat/ henti jantung/ pain (kecuali keinginan keluarga).	☐	
		5. Tidak memperhatikan keamanan pasien (pasien jatuh, tergelincir, keracunan, salah obat, salah transfusi dll).	☐	
		6. Melakukan tindakan Keperawatan yang tidak sesuai prosedur tetap yang dapat menyebabkan kematian/ kecacatan.	☐	
		7. Memberikan informasi yang tidak benar/ tidak dapat dipertanggung jawabkan.	☐	
		8. Meminta imbalan kepada pasien dan/atau keluarga Pasien.	☐	
		9. Tidak menjaga kerahasiaan pasien/ keluarga pada profesi/ orang yang berhak mengetahui.	☐	
		10. Komunikasi yang tidak baik dan dimuat di media massa/media sosial.	☐	
		11. Tidak menghargai agama pasien/ keluarga.	☐	
		12. Membedakan pelayanan keperawatan terhadap pasien berdasarkan status sosial dan martabat pasien.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Praktek	1. Berulang kali melakukan tugas yang tidak sesuai dengan prosedur tetap dan kebijakan rumah sakit yang dapat merugikan pasien secara fisik mental dan material.	☐	
		2. Tidak memegang teguh rahasia jabatan.	☐	

		3. Bekerja dengan mempertimbangkan kesukuan, jenis kelamin, aliran politik, agama dan status sosial sesuai dengan keinginan pribadi.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Lain	1. Bertengkar dengan perawat atau profesi lain.	☐	
		2. Melakukan tindakan tidak etis terhadap sesama perawat atau profesi lain. Mencedakakan perawat dan profesi lain.	☐	
		3. Mengadu domba sesama perawat atau profesi lain.	☐	
		4. Melindungi perbuatan teman yang tidak etis/praktek legal.	☐	
	Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi Keperawatan	1. Mengkomersialkan memperjual belikan harta rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau profesi keperawatan.	☐	
		2. Menjual nama organisasi profesi Keperawatan untuk kepentingan pribadi, mencari dana atas nama profesi lain untuk kepentingan pribadi, promosi produk tertentu dikaitkan dengan profesi untuk kepentingan pribadi.	☐	
		3. Menggunakan obat-obat terlarang/ alkohol/ merokok saat bertugas.	☐	
		4. Meninggalkan tugas selama lebih dari sekali dalam satu bulan ketika dinas pagi, sore, malam tanpa izin.	☐	
		5. Meninggalkan/ tidak dinas selama lebih dari satu kali dalam satu bulan tanpa izin.	☐	

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
PENYELESAIAN MASALAH ETIK DAN DISIPLIN PROFESI**

Nama Perawat :
Unit Kerja :
Level Kompetensi :

Dasar Pertimbangan Proses Pembinaan:

Pendapat Personal/Pembelaan:

Rekomendasi:

Tanggal:	Yang bersangkutan	
	Nama	
	Tanda Tangan	
	Komite Keperawatan :	
	Nama	
	Tanda Tangan	

Lampiran 4 : Laporan investigasi Pelanggaran Etik dan Disiplin Staff Keperawatan

**LAPORAN INVESTIGASI
PELANGGARAN ETIK DAN DISIPLIN STAF KEPERAWATAN**

Tim Investigasi : 1.
2.
Perihal investigasi :
Target Unit :
Waktu Pelaksanaan :

Metode investigasi :
1. Telaah dokumen
2. Wawancara
3. Observasi

Pihak yang terlibat :
Hasil investigasi :

Tim Investigasi :

Tanda Tangan :

PENGARAHAN / KONSELING
(Komite Keperawatan RS Prima Husada)

Telah dilakukan pengarahan/konseling kepada:

Nama :
Nama Unit :
Hari, tanggal :
Jam :
Jenis Pelanggaran :
Klasifikasi Pelanggaran :
Pengarahan yang diberikan :

Tanggapan staf bersangkutan :

Petugas yang Diberi Peringatan	Malang, Sub Komite Etik Keperawatan
()	()

Mengetahui,
Ketua Komite Keperawatan

()

PERINGATAN LISAN
(Komite Keperawatan RS Prima Husada)

Peringatan lisan ini diberikan kepada:

Nama :
Nama Unit :
Jenis Pelanggaran :
Klasifikasi Pelanggaran :
Tanggal Kejadian Pelanggaran :
Saksi Kejadian :

Bahwa pada waktu tersebut Saudara/i telah melakukan pelanggaran yang dimaksud. Sebagai peringatan bahwa pada waktu yang akan datang saudara/i dapat memperbaiki tingkah laku memelihara suasana kerja hubungan kerja yang lebih baik. Bilamana dikemudian hari saudara berbuat kesalahan pelanggaran yang serupa atau lainnya, maka sub Etik Komite Keperawatan akan mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	Malang,
Petugas yang Diberi Peringatan	Sub Komite Etik Keperawatan
()	()

- Tembusan:
1. Kepala Bidang Pelayanan/Keperawatan
 2. Ketua Komite Keperawatan
 3. Sumber Daya Manusia

PERINGATAN TERTULIS
(Komite Keperawatan RS Prima Husada)

Nama	:
Nama Unit	:
Jenis Pelanggaran	:
Klasifikasi Pelanggaran	:
Tanggal Kejadian Pelanggaran	:
Saksi Kejadian	:

Petugas yang Diberi Peringatan

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

1. Kepala Bidang Pelayanan/Keperawatan
2. Ketua Komite Keperawatan
3. Sumber Daya Manusia